DMS 06115

DKV Deutsche Krankenversicherung AG - 50594 Köln
BT K

**Es betreut Sie:**
Nicolai Kammerer
GS-Leiter für Bonnfinanz
Heiligkreuzstr. 22
72622 Nürtingen
Tel 07022 933110
nicolai.kammerer@
bonnfinanz.de

**Ihr Ansprechpartner:**
Vertragsservice Gesundheit
Tel 0800 3746-052*
service@dkv.com
www.dkv.com
*gebührenfrei

Februar 2026

**Versicherungsnummer:**
KV313834668



Herrn
Dr. Rainer Nitsche
Buchenweg 14
73230 Kirchheim unter Teck

Mit wenigen Klicks mehr Infos zur Beitragsanpassung:
**dkv.com/bap**
oder mobil per QR-Code.

# Beitragsänderung ab 1.4.2026
# Ihre private Krankenversicherung

Sehr geehrter Herr Dr. Nitsche,

in Ihrem Vertrag gibt es eine Beitragsänderung. Uns ist wichtig, dass Sie die Gründe dafür nachvollziehen können.

Detaillierte Informationen und insbesondere die maßgebliche(n) Rechnungsgrundlage(n) für die Beitragsänderung - das sind Versicherungsleistungen und / oder Sterbewahrscheinlichkeiten - haben wir für Sie auf einem Beiblatt zusammengefasst. Dieses finden Sie mit dem Titel **"Maßgebliche Gründe für die Beitragsanpassung"** im heutigen Brief.

Sie haben Interesse an weiteren Details? Das wollen wir Ihnen möglichst einfach machen. Deswegen stellen wir ergänzende Informationen anschaulich auf unserer Homepage **www.dkv.com/bap** für Sie bereit. Unabhängig von unseren Servicezeiten können Sie sich hier jederzeit informieren.

Ihr monatlicher Gesamtbeitrag ändert sich ab dem 1.4.2026 von **855,21 Euro um 177,17 Euro auf 1.032,38 Euro.** Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Nachtrag zur Versicherung.

Neben den Beiträgen erhöhen wir die jährliche Selbstbeteiligung.

| **Vorname Name** (versicherte Person) | **Geburtsdatum** | **Änderung der jährlichen Selbstbeteiligung** | |
|---|---|---|---|
| | | **von** | **auf** |
| Dr. Rainer Nitsche | 29.08.1966 | 430,00 Euro | 480,00 Euro |

**Was ist der Grund für die Beitragsanpassung ab 1.4.2026?**
Die gesetzlichen Vorgaben sehen vor, dass wir mindestens jährlich die erforderlichen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen vergleichen müssen. In Tarifen, für die planmäßig eine Alterungsrückstellung gebildet wird, gilt dasselbe auch für die Sterbewahrscheinlichkeiten. Falls notwendig, müssen wir die Beiträge anpassen. Dies ist nun der Fall. Dabei kann sich auch ein eventuell vereinbarter versicherungsmedizinischer Beitragszuschlag und eine betragsmäßig festgelegte Selbstbeteiligung ändern.

Ein unabhängiger Treuhänder hat die Änderungen geprüft und ihnen zugestimmt - so, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie in andere gleichartige Tarife wechseln. Möglich ist dies nach § 204 Versicherungsvertragsgesetz. Den Gesetzestext haben wir auf der Vorderseite des Beilegers "Diese Gesetzestexte sollten Sie kennen" im Wortlaut für Sie angedruckt. Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihre Versicherung ändern, um Beiträge zu sparen, verlieren Sie in der Regel einen Teil Ihres wertvollen Versicherungsschutzes.

Sie können innerhalb von zwei Monaten, nachdem Sie dieses Schreiben bekommen haben, kündigen. Das außerordentliche Kündigungsrecht gilt hinsichtlich des Versicherungsverhältnisses, das von der Beitragserhöhung betroffen ist. Geregelt ist dies in § 205 Versicherungsvertragsgesetz. Den Gesetzestext finden Sie auf der Rückseite des Beilegers "Diese Gesetzestexte sollten Sie kennen".

Dass diese Beitragsanpassung für Sie unerfreulich ist, können wir gut nachvollziehen - gerade in der aktuellen Zeit. Umso wichtiger ist ein dauerhaft zuverlässiger Versicherungsschutz. Auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld können Sie sich im Leistungsfall auf uns verlassen.

**Änderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen**
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 22.6.2022 (IV ZR 253/20) den bis dahin geltenden § 8b Absatz 2 der Musterbedingungen für die Krankheitskostenversicherung (MB/KK) für unwirksam erklärt. Dieser lautete, dass von einer Beitragsanpassung abgesehen werden kann, wenn nach übereinstimmender Beurteilung durch den Versicherer und den Treuhänder die Veränderung der Versicherungsleistungen als vorübergehend anzusehen ist. Der BGH hatte den Wortlaut der Regelung beanstandet, der von den gesetzlichen Vorgaben abweicht. § 8b Absatz 2 MB/KK und inhaltsgleiche Regelungen in Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) entfalten somit keine Rechtswirkung mehr. Wir haben daher entsprechende Regelungen in unseren AVB ersatzlos gestrichen. Nach dem Urteil des BGH tritt an die Stelle der unwirksamen Klausel die gesetzliche Regelung des § 203 Absatz 2 Satz 1 VVG. Demnach ist bei einer nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung einer für die Prämienkalkulation maßgeblichen Rechnungsgrundlage eine Neufestsetzung der Prämie ausgeschlossen. Diese Vorgabe haben wir bei Beitragsanpassungen immer umgesetzt. Das Urteil hat somit keine Auswirkungen auf bereits erfolgte Beitragsanpassungen.

**Sie möchten persönlich beraten werden?**
Sie haben Fragen, Wünsche oder Beratungsbedarf? Ihr Partner für Versicherungsfragen steht Ihnen gern zur Seite. Sie können sich auch an den Kundenservice wenden. Wir sind ebenfalls gern für Sie da.

Freundliche Grüße

Frauke Fiegl
Vorsitzende des Vorstands

Christoph Klawunn
Mitglied des Vorstands

**Versicherungsnummer:**
KV313834668

Februar 2026

**Meldung für das Steuerjahr 2026**

Folgende Werte haben wir an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt.[1]
Nehmen Sie das Schreiben zu Ihren Unterlagen. **Sie müssen sonst nichts weiter tun.**

**Gemeldete Beiträge zur Erlangung des Arbeitgeberzuschuss** (§ 257 SBG V, § 61 SGB XI)
Die ausgewiesenen Beiträge entsprechen den steuerlich auf den nächsten vollen Euro aufgerundeten Beiträgen für die zuschussfähigen Tarife. Ein eventuell gewährtes Skonto ist hierbei berücksichtigt.

Versicherte Person: **Dr. Rainer Nitsche**, geb. 29.8.1966

Steuer-Identifikationsnummer: 41673908821

| Zeitraum | Krankenversicherung | Pflegepflichtversicherung |
|---|---|---|
| 01.01. - 31.03.2026 | 743,00 EUR monatlich | 114,00 EUR monatlich |
| 01.04. - 31.12.2026 | 920,00 EUR monatlich | 114,00 EUR monatlich |

**Gemeldete Beiträge für Vorsorgeaufwendungen** (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG)
Die hier angegebenen steuerlich auf den nächsten vollen Euro aufgerundeten Beitragsanteile sind in der Regel niedriger als die tatsächlich zu zahlenden, da die steuerabzugsfähigen Beträge auf Grundlage einer Basisabsicherung zu berechnen sind.

Versicherte Person: **Dr. Rainer Nitsche**, geb. 29.8.1966

Steuer-Identifikationsnummer: 41673908821

| Zeitraum | Krankenversicherung | Pflegepflichtversicherung |
|---|---|---|
| 01.01. - 31.03.2026 | 554,00 EUR monatlich | 114,00 EUR monatlich |
| 01.04. - 31.12.2026 | 695,00 EUR monatlich | 114,00 EUR monatlich |

Sie benötigen die digitale Datenübermittlung nicht mehr?
Dann können Sie ganz einfach widersprechen. Am schnellsten und einfachsten geht dies online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder geben Sie www.dkv.com/JStG2020 ein.

[1] Es wurden keine Daten übermittelt, wenn im betreffenden Feld kein Wert (Strich) angezeigt wird.

**Versicherungsnummer:**
KV313834668

Mobil per
QR-Code zum
Widerspruch

Unter www.dkv.com/JStG2020 finden Sie auch weitere Informationen zu den Auswirkungen des Jahressteuergesetzes.

Bei allen steuerrechtlichen Fragen können Sie sich an Ihr Finanzamt oder einen Steuerberater wenden. Wir dürfen Ihnen als Krankenversicherer keine steuerrechtlichen Fragen beantworten.

Versicherungsnummer:
**KV 313834668**

# Nachtrag zur Versicherung
aus Februar 2026

Gruppenvertragspartner: Verein Deutscher Ingenieure (VDI) e.V.

Mitglied im Gruppenvertrag: Dr. Rainer Nitsche

**Vertragsstand ab: 1.4.2026**

---

**Versicherte Person:** **Dr. Rainer Nitsche**
29.8.1966

| Tarif, Kurzerläuterung | Bisheriger Zahlbeitrag in Euro | Beitragsveränderung in Euro | Neuer Zahlbeitrag ggf. Obergrenze in Euro |
|---|---|---|---|
| **BestMed Komfort BM4 / 1**<br>jährliche Selbstbeteiligung über alle Leistungsbereiche insgesamt 480 EUR<br>100 % ambulante ärztliche Leistungen<br>- Psychotherapie nach vorheriger Zusage zu 100 % bis 30 Sitzungen, zu 80 % ab der 31. Sitzung, zu 70 % ab der 61. Sitzung<br>- Alternativmedizin inklusive Arzneimittel nach gültigem Hufelandverzeichnis zu 80 %, maximal 1.000 EUR pro Jahr<br>100 % Arznei- und Verbandmittel<br>100 % Heilmittel im Rahmen des Heilmittelverzeichnisses<br>100 % "große" Hilfsmittel, sofern diese über DKV-Service bezogen werden, ansonsten 80 %<br>100 % "kleine" Hilfsmittel<br>80 % Leistungen des Heilpraktikers inklusive Arzneimittel, maximal 1.000 EUR pro Jahr<br>100 % Zahnbehandlung inklusive Prophylaxeleistungen,<br>85 % Einlagefüllungen (Inlays), Zahnkronen und Zahnersatz (bis zu 6 Implantate je Kiefer einschließlich bereits vorhandener), sofern Behandlung durch einen mit der DKV kooperierenden Zahnarzt erfolgt, anderenfalls 75 %<br>100 % Kieferorthopädie bei Behandlungsbeginn vor dem 19. Geburtstag<br>- begrenzte Erstattung in den ersten 5 Versicherungsjahren für zahnärztliche Leistungen, ausgenommen Zahnbehandlung inklusive Prophylaxeleistungen sowie Kieferorthopädie<br>100 % stationäre Behandlung im Zweibettzimmer und wahlärztliche Leistungen<br><br>Die jährliche Selbstbeteiligung ändert sich für Männer von 430,00 EUR auf **480,00 EUR**.<br>In diesem Jahr der Anpassung beträgt die Selbstbeteiligung maximal 467,50 EUR.<br>Ab dem folgenden Jahr gilt die tarifliche Selbstbeteiligung in voller Höhe. | **632,39** | **+ 161,06** | **793,45** |
| TC 43<br>105 EUR Krankentagegeld ab dem 43. Tag | 46,39 | - | 46,39 |
| PVN<br>Private Pflegepflichtversicherung | 113,19 | - | 113,19 |
| **GBZ**<br>Gesetzlicher Beitragszuschlag | **63,24** | **+ 16,11** | **79,35** |
| **Monatlicher Gesamtbeitrag:** | **855,21** | **+ 177,17** | **1.032,38** |

In dem neuen zu zahlenden Beitrag ist berücksichtigt:

| | |
|---|---|
| Beitragsminderung aus der Alterungsrückstellung*[1]: | 451,83 Euro |

---

Da wir die Beiträge abbuchen, brauchen Sie nichts zu unternehmen.

---

*[1] Beitragsminderung aus der Alterungsrückstellung:
Wozu dient die Alterungsrückstellung? Ältere Versicherte nehmen Gesundheitsleistungen häufiger in Anspruch. Deshalb stellen wir einen Teil des Beitrages in jüngeren Jahren zurück und legen ihn verzinslich an. Damit können wir die im Alter zu erwartenden Mehrkosten decken und eine altersbedingte Erhöhung der Beiträge ausschließen. Alterungsrückstellungen bilden wir nur für Tarife, die wir nach Art der Lebensversicherung kalkulieren.

Ausnahme:
Alterungsrückstellungen für Kinder und Jugendliche werden nur ausnahmsweise gebildet. Hintergrund sind meist Limitierungen aus Beitragsanpassungen. Diese Alterungsrückstellungen sind so kalkuliert, dass diese bei Eintritt in den Beitrag für Erwachsene verbraucht sind.

Hinweis:
Sie haben mit uns eine Anwartschaftsversicherung vereinbart? Für diese Tarife (außer Pflegepflichtversicherung) weisen wir die Alterungsrückstellungen hier nicht aus. Sie bleiben wie vereinbart erhalten und werden fortgeführt. Endet die Anwartschaft, werden die Alterungsrückstellungen wieder beitragsmindernd angerechnet.

**Wichtige Hinweise:**

*Hinweis zu den Kurzerläuterungen:*
Genaue Leistungsbeschreibungen und weitere Informationen finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

**Bisher bestehende Besondere Vereinbarungen gelten weiter.**

Beantragte Vertragsänderungen sind in diesem Nachtrag und im monatlichen Gesamtbeitrag noch nicht berücksichtigt. Wenn wir die Änderungen durchgeführt haben, informieren wir Sie wieder.

Die Versicherung, für die keine Versicherungssteuer ausgewiesen wird, ist gemäß
§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b Versicherungssteuergesetz (VersStG) in der Fassung ab 1.1.2022 bzw. § 4 Nr. 5 VersStG in der Fassung bis 31.12.2021 von der Versicherungssteuer befreit.
Unsere Versicherungssteuernummer lautet: 800/V20000048669.

Der oben genannte Beitrag ist umsatzsteuerfrei. Unsere Umsatzsteuer-Identifikationsnummer lautet: DE123489120.

**DKV Deutsche Krankenversicherung AG** **Hauptverwaltung: 50933 Köln, Aachener Straße 300**

Freundliche Grüße

Frauke Fiegl
Vorsitzende des Vorstands

Christoph Klawunn
Mitglied des Vorstands

**Maßgebliche Gründe für Ihre Beitragsanpassung ab 1.4.2026**
Gern erläutern wir Ihnen die maßgeblichen Gründe für die Neufestsetzung Ihres Beitrags.

Ist bei einer Krankenversicherung, zu der auch die Pflegepflicht- und Pflegezusatzversicherung zählen, das ordentliche Kündigungsrecht des Versicherers ausgeschlossen, sind wir bei einer dauerhaften Veränderung einer für die Beitragskalkulation maßgeblichen Rechnungsgrundlage berechtigt, die Beiträge entsprechend den dann insgesamt berichtigten Rechnungsgrundlagen auch für bestehende Versicherungsverhältnisse neu festzusetzen. Dabei dürfen wir auch eine betragsmäßig festgelegte Selbstbeteiligung und einen Risikozuschlag (versicherungsmedizinischer Zuschlag) entsprechend ändern, soweit dies vereinbart ist (vgl. § 155 Abs. 3 VAG i.V.m. § 203 Abs. 2 VVG).

Im Laufe der Zeit verändern sich die für eine Beitragsanpassung maßgeblichen Rechnungsgrundlagen. Gründe dafür sind beispielsweise die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege, der medizinische Fortschritt mit neuen Behandlungsmethoden, die steigende Anzahl von Pflegebedürftigen und längere Pflegedauern oder eine veränderte Lebenserwartung. Maßgebliche Rechnungsgrundlagen können daher die Versicherungsleistungen oder die Sterbewahrscheinlichkeiten sein.

Der gesetzlich vorgeschriebene Vergleich der erforderlichen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen sowie der erforderlichen mit den kalkulierten Sterbewahrscheinlichkeiten erfolgt mindestens jährlich für jede Beobachtungseinheit eines Tarifs. Beobachtungseinheiten sind je nach Tarif beispielsweise bei geschlechtsabhängig kalkulierten Beiträgen "Männer" und "Frauen" oder bei geschlechtsunabhängig kalkulierten Beiträgen "Erwachsene". Zusätzlich kann es beispielsweise auch die Beobachtungseinheiten "Kinder" oder "Jugendliche" geben.

Der gesetzliche Schwellenwert für die Abweichung der Versicherungsleistungen beträgt 10 Prozent. Wir dürfen in unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen jedoch auch einen niedrigeren Prozentsatz festlegen. In einigen Tarifen gilt daher nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Versicherungsleistungen ein geringerer Prozentsatz von 5 Prozent. In diesen Tarifen passen wir die Beiträge falls erforderlich an, wenn dieser vertraglich festgelegte Schwellenwert überschritten ist. Für die Abweichung der Sterbewahrscheinlichkeiten beträgt der gesetzliche Schwellenwert 5 Prozent.

Wenn entweder bei einer von diesen beiden oder ggf. auch bei beiden Rechnungsgrundlagen eine nicht nur vorübergehende Veränderung eingetreten ist, die größer als der für Ihren Vertrag im jeweiligen Tarif zugrunde zu legende Schwellenwert ist, sind wir berechtigt, die Beiträge neu festzusetzen.

Der unabhängige Treuhänder prüft auch im Interesse der Kunden, ob wir die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Er hat der Beitragsanpassung zugestimmt.

**Welche Informationen sind nachfolgend aufgeführt?**
Für jede versicherte Person werden in einer separaten Tabelle die Tarife dargestellt, **in denen wir aufgrund der Veränderung einer maßgeblichen Rechnungsgrundlage über dem gesetzlich bzw. tariflich festgelegten Schwellenwert eine Beitragsanpassung vorgenommen haben.** Angegeben werden die Rechnungsgrundlagen, bei denen eine Überschreitung des definierten Schwellenwerts eingetreten ist und bei denen zudem die Veränderungen nicht nur vorübergehend waren. Gemäß § 203 Abs. 2 VVG können dies die Versicherungsleistungen oder die Sterbewahrscheinlichkeiten oder beide sein.

**Versicherte Person:** **Dr. Rainer Nitsche**
29.8.1966

| Tarif / Beitragsentlastungsvereinbarung | Maßgebliche Rechnungsgrundlage/n |
|---|---|
| BestMed Komfort BM4 / 1 | Versicherungsleistungen |

# Diese Gesetzestexte sollten Sie kennen

## Ihr Tarifwechselrecht nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

**§ 204 VVG Tarifwechselrecht**

(1) Bei bestehendem Versicherungsverhältnis kann der Versicherungsnehmer vom Versicherer verlangen, dass dieser

1. Anträge auf Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung annimmt; soweit die Leistungen in dem Tarif, in den der Versicherungsnehmer wechseln will, höher oder umfassender sind als in dem bisherigen Tarif, kann der Versicherer für die Mehrleistung einen Leistungsausschluss oder einen angemessenen Risikozuschlag und insoweit auch eine Wartezeit verlangen; der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung eines Risikozuschlages und einer Wartezeit dadurch abwenden, dass er hinsichtlich der Mehrleistung einen Leistungsausschluss vereinbart; bei einem Wechsel aus dem Basistarif in einen anderen Tarif kann der Versicherer auch den bei Vertragsschluss ermittelten Risikozuschlag verlangen; der Wechsel in den Basistarif des Versicherers unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung ist nur möglich, wenn
   a) die bestehende Krankheitskostenversicherung nach dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde oder
   b) der Versicherungsnehmer das 55. Lebensjahr vollendet hat oder das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, aber die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt und diese Rente beantragt hat oder ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften bezieht oder hilfebedürftig nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch ist oder
   c) die bestehende Krankheitskostenversicherung vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde und der Wechsel in den Basistarif vor dem 1. Juli 2009 beantragt wurde;

   ein Wechsel aus einem Tarif, bei dem die Prämien geschlechtsunabhängig kalkuliert werden, in einen Tarif, bei dem dies nicht der Fall ist, ist ausgeschlossen;
2. bei einer Kündigung des Vertrags und dem gleichzeitigen Abschluss eines neuen Vertrags, der ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorgesehenen Krankenversicherungsschutz ersetzen kann, bei einem anderen Krankenversicherer
   a) die kalkulierte Alterungsrückstellung des Teils der Versicherung, dessen Leistungen dem Basistarif entsprechen, an den neuen Versicherer überträgt, sofern die gekündigte Krankheitskostenversicherung nach dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde;
   b) bei einem Abschluss eines Vertrags im Basistarif die kalkulierte Alterungsrückstellung des Teils der Versicherung, dessen Leistungen dem Basistarif entsprechen, an den neuen Versicherer überträgt, sofern die gekündigte Krankheitskostenversicherung vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde und die Kündigung vor dem 1. Juli 2009 erfolgte.

Soweit die Leistungen in dem Tarif, aus dem der Versicherungsnehmer wechseln will, höher oder umfassender sind als im Basistarif, kann der Versicherungsnehmer vom bisherigen Versicherer die Vereinbarung eines Zusatztarifes verlangen, in dem die über den Basistarif hinausgehende Alterungsrückstellung anzurechnen ist. Auf die Ansprüche nach den Sätzen 1 und 2 kann nicht verzichtet werden.

(2) Ist der Versicherungsnehmer auf Grund bestehender Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch nach dem 15. März 2020 in den Basistarif nach § 152 des Versicherungsaufsichtsgesetzes gewechselt und endet die Hilfebedürftigkeit des Versicherungsnehmers innerhalb von zwei Jahren nach dem Wechsel, kann er innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Hilfebedürftigkeit in Textform vom Versicherer verlangen, den Vertrag ab dem ersten Tag des übernächsten Monats in dem Tarif fortzusetzen, in dem der Versicherungsnehmer vor dem Wechsel in den Basistarif versichert war. Eintritt und Beendigung der Hilfebedürftigkeit hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers durch geeignete Unterlagen nachzuweisen; die Bescheinigung des zuständigen Trägers nach dem Zweiten oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch gilt als Nachweis. Beim Wechsel ist der Versicherungsnehmer so zu stellen, wie er vor der Versicherung im Basistarif stand; die im Basistarif erworbenen Rechte und Alterungsrückstellungen sind zu berücksichtigen. Prämienanpassungen und Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen in dem Tarif, in dem der Versicherungsnehmer vor dem Wechsel in den Basistarif versichert war, gelten ab dem Tag der Fortsetzung des Vertrages in diesem Tarif. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Versicherungsnehmer, bei denen allein durch die Zahlung des Beitrags Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch entstehen würde. Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 letzter Teilsatz gilt nicht.

(3) Im Falle der Kündigung des Vertrags zur privaten Pflege-Pflichtversicherung und dem gleichzeitigen Abschluss eines neuen Vertrags bei einem anderen Versicherer kann der Versicherungsnehmer vom bisherigen Versicherer verlangen, dass dieser die für ihn kalkulierte Alterungsrückstellung an den neuen Versicherer überträgt. Auf diesen Anspruch kann nicht verzichtet werden.

(4) Absatz 1 gilt nicht für befristete Versicherungsverhältnisse. Handelt es sich um eine Befristung nach § 196, besteht das Tarifwechselrecht nach Absatz 1 Nummer 1.

(5) Soweit die Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, haben die Versicherungsnehmer und die versicherte Person das Recht, einen gekündigten Versicherungsvertrag in Form einer Anwartschaftsversicherung fortzuführen.

DKV
Deutsche Krankenversicherung

# Ihr Kündigungsrecht nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

**§ 205 VVG Kündigungsrecht**

...

(3) Ergibt sich aus dem Versicherungsvertrag, dass bei Erreichen eines bestimmten Lebensalters oder bei Eintreten anderer dort genannter Voraussetzungen die Prämie für ein anderes Lebensalter oder eine andere Altersgruppe gilt oder die Prämie unter Berücksichtigung einer Alterungsrückstellung berechnet wird, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person binnen zwei Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens kündigen, wenn sich die Prämie durch die Änderung erhöht.

(4) Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie oder vermindert er die Leistung, kann der Versicherungsnehmer hinsichtlich der betroffenen versicherten Person innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt kündigen, zu dem die Prämienerhöhung oder die Leistungsminderung wirksam werden soll.

...

(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 5 kann der Versicherungsnehmer eine Versicherung, die eine Pflicht aus § 193 Abs. 3 Satz 1 erfüllt, nur dann kündigen, wenn er bei einem anderen Versicherer für die versicherte Person einen neuen Vertrag abschließt, der dieser Pflicht genügt. Die Kündigung wird nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb von zwei Monaten nach der Kündigungserklärung nachweist, dass die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist; liegt der Termin, zu dem die Kündigung ausgesprochen wurde, mehr als zwei Monate nach der Kündigungserklärung, muss der Nachweis bis zu diesem Termin erbracht werden.

Versicherungsnummer:
**KV 313834668**

# Informationsblatt zu Umstellungsmöglichkeiten

aus Februar 2026

| | |
|---|---|
| Gruppenvertragspartner: | Verein Deutscher Ingenieure (VDI) e.V. |
| Mitglied im Gruppenvertrag: | Dr. Rainer Nitsche |
| **Umstellungsvorschlag ab:** | **1.4.2026** |

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Umstellungsvorschläge zu dem bestehenden Versicherungsschutz.

Bei einigen Vorschlägen gibt es Besonderheiten zu beachten. Diese haben wir für Sie vor dem jeweiligen Umstellungsvorschlag zusammengefasst. Bitte lesen Sie sich diese wichtigen Informationen aufmerksam durch und berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Entscheidung.

Sie denken über eine Tarifumstellung nach? Rufen Sie uns einfach an! Gern besprechen wir mit Ihnen, welcher Tarif Ihren individuellen Wünschen entsprechen würde.

Sie können sich auch online im **Tarifcheck** über Alternativen zu Ihrem bestehenden Versicherungsschutz informieren. Dafür brauchen Sie sich nur auf unserer Website www.dkv.com/meine-versicherungen für Ihr persönliches Kundenportal zu registrieren.
Im Tarifcheck können Sie auch ganz unkompliziert Tarifgegenüberstellungen zu den vorgeschlagenen Tarifen anfordern. Mit diesen erhalten Sie einen Überblick über die Tarifleistungen und Veränderungen zu Ihrem aktuell versicherten Tarif.

**Übrigens: 96 % unserer Kunden führen nach einer Beitragsanpassung ihren Versicherungsschutz unverändert fort.**
**Wenn Sie keine Tarifumstellung wünschen, brauchen Sie nichts zu unternehmen.**

Eine Tarifumstellung ist meist nur auf den ersten Blick attraktiv. Wenn Sie über eine Umstellung Ihrer Versicherung nachdenken, beachten Sie bitte folgendes:

| | |
|---|---|
| **Bringt eine Tarifumstellung Nachteile mit sich?** | Einer Beitragsersparnis im neuen Tarif können Verschlechterungen beim Versicherungsschutz gegenüberstehen. |
| **Kann der Versicherungsschutz später problemlos wieder erhöht werden?** | Eine spätere Erweiterung des Versicherungsschutzes ist möglich - **aber nur mit einer erneuten Gesundheitsprüfung!** Auch wenn zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal ein höherer Versicherungsschutz bestanden hat.<br>Die Gesundheitsprüfung kann beispielsweise dazu führen, dass wir Ihnen den gewünschten Tarif nur mit einem versicherungsmedizinischen Zuschlag anbieten können. Dieser Zuschlag wird für eine Erkrankung erhoben, die Einfluss auf die voraussichtlichen Krankheitskosten der versicherten Person hat. |
| **Kann es im neuen Tarif künftig auch zu Beitragserhöhungen kommen?** | Ja, **auch in Ihrem neuen Tarif kann es künftig zu Beitragserhöhungen** kommen.<br>Dabei dürfen wir auch eine festgelegte Selbstbeteiligung ändern. |

| | |
|---|---|
| **Ändert sich der Anspruch auf eine Beitragsrückerstattung?** | Die Voraussetzungen für einen für einen eventuellen **Anspruch auf eine Beitragsrückerstattung (BRE) können sich ändern**. Beispielsweise können Leistungen im neuen Tarif BRE-schädlich sein, die im bisherigen Tarif keinen Einfluss auf eine mögliche BRE hatten. Das sind z.B. Vorsorgeuntersuchungen oder stationäre Leistungen.<br>Der Anspruch auf eine BRE kann ganz entfallen, wenn der neue Tarif eine bestimmte Versicherungsdauer dafür voraussetzt. Oder auch bei einem Wechsel in den Standard- oder Basistarif. |
| **Im Ausland kann sich eine Tarifumstellung als nachteilig auswirken.** | Warum ist das so? Eine Beitragsersparnis ist in der Regel mit einem geringeren Leistungsumfang verbunden. Im Ausland finden Sie andere Gegebenheiten als in Deutschland vor. Unsere Tarife sind jedoch auf das deutsche Gesundheitssystem zugeschnitten. Daher können Tarifwechsel zu einer Unterdeckung führen.<br>- Ein Wechsel in den Basistarif ist nur möglich, wenn der gewöhnliche Aufenthalt der versicherten Person in Deutschland ist.<br>- Ein Wechsel in den Standardtarif ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen für den Standardtarif gegeben sind. Außerdem muss der gewöhnliche Aufenthalt der versicherten Person innerhalb der Europäischen Union (EU) sein. |
| **Gesundheitsprüfung und versicherungsmedizinischer Zuschlag bei Tarifumstellungen** | Bei Umstellungsvorschlägen in einen Tarif mit höheren Leistungen haben wir auf Basis der uns vorliegenden Informationen eine Gesundheitsprüfung durchgeführt. Diese hat für den Einschluss der Mehrleistungen einen zusätzlichen versicherungsmedizinischen Zuschlag ergeben.<br>Alternativ können Sie die besseren Leistungen des neuen Tarifs vom Versicherungsschutz ausschließen. Diese Einschränkung bezieht sich auf alle Mehrleistungen im neuen Tarif und ist nicht auf bestimmte Krankheiten begrenzt. |

Einen Tarifwechsel ab 1.4.2026 können Sie ganz einfach mit den vorgeschlagenen Optionen bis zum **30.4.2026** beantragen.

**Versicherte Person:** **Dr. Rainer Nitsche**
29.8.1966

**Vorschlag 1**
Individueller Umstellungsvorschlag mit Orientierung am bestehenden Versicherungsschutz und Beitragssenkung.

| Tarif, Kurzerläuterung | Neuer zu zahlender Beitrag ggf. Obergrenze Euro |
|---|---|
| **BestMed Komfort BM4 / 2**<br>jährliche Selbstbeteiligung über alle Leistungsbereiche insgesamt 900 EUR<br>100 % ambulante ärztliche Leistungen<br>- Psychotherapie nach vorheriger Zusage zu 100 % bis 30 Sitzungen, zu 80 % ab der 31. Sitzung, zu 70 % ab der 61. Sitzung<br>- Alternativmedizin inklusive Arzneimittel nach gültigem Hufelandverzeichnis zu 80 %, maximal 1.000 EUR pro Jahr<br>100 % Arznei- und Verbandmittel<br>100 % Heilmittel im Rahmen des Heilmittelverzeichnisses<br>100 % "große" Hilfsmittel, sofern diese über DKV-Service bezogen werden, ansonsten 80 %<br>100 % "kleine" Hilfsmittel<br>80 % Leistungen des Heilpraktikers inklusive Arzneimittel, maximal 1.000 EUR pro Jahr<br>100 % Zahnbehandlung inklusive Prophylaxeleistungen,<br>85 % Einlagefüllungen (Inlays), Zahnkronen und Zahnersatz (bis zu 6 Implantate je Kiefer einschließlich bereits vorhandener), sofern Behandlung durch einen mit der DKV kooperierenden Zahnarzt erfolgt, anderenfalls 75 %<br>100 % Kieferorthopädie bei Behandlungsbeginn vor dem 19. Geburtstag<br>- begrenzte Erstattung in den ersten 5 Versicherungsjahren für zahnärztliche Leistungen, ausgenommen Zahnbehandlung inklusive Prophylaxeleistungen sowie Kieferorthopädie<br>100 % stationäre Behandlung im Zweibettzimmer und wahlärztliche Leistungen | **702,18** |
| TC 43<br>105 EUR Krankentagegeld ab dem 43. Tag | 46,39 |
| PVN<br>Private Pflegepflichtversicherung | 113,19 |
| **GBZ**<br>Gesetzlicher Beitragszuschlag | **70,22** |
| **Monatlicher Gesamtbeitrag:** | **931,98** |

**Beitragsänderung gegenüber dem neuen Beitrag in den bisherigen Tarifen:** **- 100,40**

In dem neuen zu zahlenden Beitrag ist berücksichtigt:

Beitragsminderung aus der Alterungsrückstellung*[1]: 451,83 Euro

Ist bei diesem Tarif BestMed Komfort BM4/2 lediglich der Unterschied, dass der Selbstbehalt von 480€/y auf 900€/y steigt, dafür aber pro Monat um 100€/m günstiger ist? Dann wäre das ja eine klare Sache....
28.02.2026 - nitr

**Versicherte Person:** **Dr. Rainer Nitsche**
29.8.1966

**Vorschlag 2**
Umstellungsvorschlag zu einem der Tarife mit höchstem Neuzugang und Beitragssenkung; hierzu sind wir gesetzlich verpflichtet.

Bei diesem Umstellungsvorschlag beachten Sie bitte die folgenden **Nachteile:**

Diese Tarifstufe sieht keine Beitragsrückerstattung vor.

| Tarif, Kurzerläuterung | Neuer zu zahlender Beitrag ggf. Obergrenze Euro |
|---|---|
| **VollMed M4 - BR0**<br>100 % ambulante ärztliche Leistungen, Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen<br>100 % Arznei-, Verband-, Heilmittel (z.B. Massagen, Ergotherapie) und Hilfsmittel<br>100 % Heilpraktikerleistungen<br>80 % Psychotherapie bis zu 50 Sitzungen im Versicherungsjahr<br>100 % Zahnbehandlung, Einlagefüllungen, Zahnprophylaxe inkl. Zahnreinigung<br>80 % Zahnkronen, Zahnersatz inkl. Implantate<br>80 % Kieferorthopädie bei Behandlungsbeginn vor dem 18. Geburtstag oder bei Unfall (100 % bei erfolgreichem Abschluss)<br>jährliche Selbstbeteiligung für ambulante und zahnärztliche Heilbehandlung insgesamt 1.320 EUR<br>100 % stationäre Behandlung im Ein- oder Zweibettzimmer und wahlärztliche Leistungen<br>Notrufservice, Gesundheitstelefon | **769,02** |
| TC 43<br>105 EUR Krankentagegeld ab dem 43. Tag | 46,39 |
| PVN<br>Private Pflegepflichtversicherung | 113,19 |
| **GBZ**<br>Gesetzlicher Beitragszuschlag | **62,01** |
| **Monatlicher Gesamtbeitrag:** | **990,61** |
| **Beitragsänderung gegenüber dem neuen Beitrag in den bisherigen Tarifen:** | **- 41,77** |

In dem neuen zu zahlenden Beitrag ist berücksichtigt:

| | |
|---|---|
| Beitragsminderung aus der Alterungsrückstellung*[1]: | 470,61 Euro |
| Bereits bestehender versicherungsmedizinischer Zuschlag und / oder hinzukommender Zuschlag aufgrund höherer Leistungen des angebotenen Tarifs: | 148,90 Euro |

Wenn wir Ihnen den neuen Tarif aufgrund höherer Leistungen nur mit einem versicherungsmedizinischen Zuschlag anbieten können, können stattdessen die Mehrleistungen eventuell ausgeschlossen werden. Bei Interesse beraten wir Sie gern telefonisch.

**Versicherte Person:** **Dr. Rainer Nitsche**
29.8.1966

**Vorschlag 3**
Umstellungsvorschlag zu einem der Tarife mit höchstem Neuzugang und Beitragssenkung; hierzu sind wir gesetzlich verpflichtet.

Bei diesem Umstellungsvorschlag beachten Sie bitte die folgenden **Nachteile:**

- Zusätzliche Eigenbeteiligung möglich: (Zahn-)Ärztliche Leistungen nur bis zu den Regelhöchstsätzen der GOÄ/GOZ versichert (2,3facher Satz). Rechnet der (Zahn-)Arzt höhere Sätze ab, tragen Sie die Differenz - in der Zahnmedizin kann dies häufiger der Fall sein
- Budgetregel bei Zahnersatz: Erstattung begrenzt auf 60% bis maximal 4.000 Euro unter Anrechnung der beiden vorangegangenen Jahre
- Heilmittel wie Physiotherapie (z.B. Massagen), Osteopathie, Ergotherapie usw. insgesamt maximal 30 Anwendungen pro Jahr
- Psychotherapie begrenzt auf maximal 50 Sitzungen pro Jahr nach vorheriger Zusage. 100% Erstattung nur für die ersten 20 Sitzungen, danach nur noch 70%
- Große Hilfsmittel (z.B. Stützapparate, Sauerstoffgeräte, Absauggeräte) bevorzugt auf Leihbasis, sonst unter Voraussetzung der medizinischen Notwendigkeit einmal alle drei Jahre (z.B. Hörgeräte)
- Keine Leistungen für Heilpraktiker

| Tarif, Kurzerläuterung | Neuer zu zahlender Beitrag ggf. Obergrenze Euro |
|---|---|
| **ET 1**<br>jährliche Selbstbeteiligung über alle Leistungsbereiche insgesamt 480 EUR<br>100 % ambulante ärztliche Leistungen<br>100 % Arznei-, Verband- und Hilfsmittel (große Hilfsmittel ohne Leihmöglichkeit nur alle 3 Jahre)<br>100 % Heilmittel (z. B. Massagen, Ergotherapie) für maximal 30 Anwendungen pro Jahr<br>Psychotherapie nach vorheriger Zusage bis zu 50 Sitzungen pro Jahr<br>100 % für die ersten 20 Sitzungen, danach 70 %<br>Heilpraktikerleistungen sind nicht erstattungsfähig<br>100 % Zahnbehandlung, Zahnprophylaxe inkl. Zahnreinigung<br>60 % Zahnersatz, Einlagefüllungen und Kieferorthopädie<br>- begrenzte Leistungen in den ersten 4 Versicherungsjahren, danach insgesamt max. 4.000 EUR unter Anrechnung der Erstattungen der beiden vorangegangenen Versicherungsjahre<br>100 % stationäre Behandlung im Mehrbettzimmer und Belegarzt<br>Notrufservice, Gesundheitstelefon | **559,86** |
| **SB 2**<br>100 % Wahlleistung Zweibettzimmer und wahlärztliche Leistungen | **51,53** |
| TC 43<br>105 EUR Krankentagegeld ab dem 43. Tag | 46,39 |
| PVN<br>Private Pflegepflichtversicherung | 113,19 |
| **GBZ**<br>Gesetzlicher Beitragszuschlag | **61,14** |

| | |
|---|---|
| **Monatlicher Gesamtbeitrag:** | **832,11** |
| **Beitragsänderung gegenüber dem neuen Beitrag in den bisherigen Tarifen:** | **- 200,27** |

In dem neuen zu zahlenden Beitrag ist berücksichtigt:

| | |
|---|---|
| Beitragsminderung aus der Alterungsrückstellung*[1]: | 450,28 Euro |

**Versicherte Person:** **Dr. Rainer Nitsche**
29.8.1966

**Vorschlag 4**
Zu diesem Umstellungsvorschlag sind wir gesetzlich verpflichtet, auch wenn die Umstellung in diesen Tarif nicht zu einer Beitragssenkung führt.

Bei diesem Umstellungsvorschlag beachten Sie bitte die folgenden **Nachteile:**

- Die Leistungen des Standardtarifs entsprechen dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
- Kein Anspruch auf Wahlleistungen wie Chefarzt und Ein- oder Zweibettzimmer.
- Leistungen nur für öffentliche und private Krankenhäuser, die der Bundespflegesatzverordnung bzw. dem Krankenhausentgeltgesetz unterliegen.
- Keine Leistungen bis zu den Regelhöchstsätzen GOÄ / GOZ. Für persönliche Leistungen sind maximal der 1,8fache Satz der GOÄ und der 2,0fache Satz der GOZ erstattungsfähig. Ärzte ohne Kassenzulassung sind nicht verpflichtet, Sie zu diesen reduzierten Sätzen zu behandeln.
- Nur verschreibungspflichtige Arzneimittel.
- Maximal 2 Implantate im zahnlosen Unterkiefer versichert.
- Beginnt der Standardtarif nicht am 1. Januar eines Jahres, ist die anteilige Selbstbeteiligung immer zu erfüllen. Auch dann, wenn die Jahresselbstbeteiligung für den Tarif, der vor der Umstellung bestand, bereits teilweise oder vollständig erbracht wurde.
- Grundsätzlich keine Beitragsrückerstattung (BRE)! Bei Wechsel in den Standardtarif geht ein Anspruch auf BRE aus den bisher versicherten Tarifen verloren. Bei einer Umstellung vor dem 1.7. entfällt zusätzlich ein Anspruch auf BRE für das vergangene Geschäftsjahr.
- Es darf keine weitere Krankheitskostenversicherung geführt oder hinzuversichert werden (auch nicht bei einem anderen Versicherungsunternehmen). Weder als Zusatz- noch als Vollversicherung. Eine Ausnahme sind Krankentagegeld- und Auslandsreiseversicherungen.
- Eine bestehende Beitragsentlastungsvereinbarung muss beim Wechsel entfallen.
- Serviceprodukte wie Best Care und KombiMed BestCare können Sie nicht weiterführen.

In den Standardtarif können Versicherte ab Vollendung des 65. Lebensjahres wechseln, die bereits vor dem 1.1.2009 eine private Krankheitskostenvollversicherung bei uns abgeschlossen haben.

Außerdem können Personen in den Tarif wechseln, wenn:
- die zu versichernde Person das 55. Lebensjahr vollendet hat oder
- die zu versichernde Person vor Vollendung des 55. Lebensjahres eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht oder die Voraussetzungen für diese erfüllt und sie beantragt hat.

Zusätzlich darf ihr jährliches Gesamteinkommen die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 Sozialgesetzbuch V nicht übersteigen. Im Jahr 2026 beträgt diese 69.750 Euro.

| Tarif, Kurzerläuterung | Neuer zu zahlender Beitrag ggf. Obergrenze Euro |
|---|---|
| **STN**<br>ambulante ärztliche Leistungen<br>Zahnbehandlung, Zahnersatz, Kieferorthopädie<br>stationäre Behandlung im Mehrbettzimmer und Belegarzt in tariflich vorgesehener Höhe.<br>Selbstbeteiligung für Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel von 306 EUR/Jahr.<br>Im Tarif sind weitere Eigenanteile vorgesehen. | **446,66** |
| TC 43<br>105 EUR Krankentagegeld ab dem 43. Tag | 46,39 |

| | |
|---|---|
| PVN<br>Private Pflegepflichtversicherung | 113,19 |
| **GBZ**<br>Gesetzlicher Beitragszuschlag | **44,67** |
| **Monatlicher Gesamtbeitrag:** | **650,91** |
| **Beitragsänderung gegenüber dem neuen Beitrag in den bisherigen Tarifen:** | **- 381,47** |

In dem neuen zu zahlenden Beitrag ist berücksichtigt:

| | |
|---|---|
| Beitragsminderung aus der Alterungsrückstellung*[1]: | 419,47 Euro |

**Versicherte Person:** **Dr. Rainer Nitsche**
29.8.1966

**Vorschlag 5**
Zu diesem Umstellungsvorschlag sind wir gesetzlich verpflichtet, auch wenn die Umstellung in diesen Tarif nicht zu einer Beitragssenkung führt.

Bei diesem Umstellungsvorschlag beachten Sie bitte die folgenden **Nachteile:**

- Die Leistungen des Basistarifs sind vergleichbar mit denen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
- Kein Anspruch auf Wahlleistungen wie Chefarzt und Ein- oder Zweibettzimmer.
- Leistungen nur für Kliniken, die Verträge mit der gesetzlichen Krankenversicherung haben.
- Keine Leistungen bis zu den Regelhöchstsätzen GOÄ / GOZ. Für persönliche Leistungen sind maximal der 1,2fache Satz der GOÄ und der 2,0fache Satz der GOZ erstattungsfähig. Erstattungsfähig sind nur Behandlungen, die von GKV-Vertragsärzten durchgeführt wurden.
- Nur verschreibungspflichtige Arzneimittel.
- Grundsätzlich keine Beitragsrückerstattung (BRE)! Bei Wechsel in den Basistarif, geht ein Anspruch auf eine BRE aus den bisher versicherten Tarifen verloren. Bei einer Umstellung vor dem 1.7. entfällt zusätzlich der Anspruch auf BRE für das vergangene Geschäftsjahr.
- Eine bestehende Beitragsentlastungsvereinbarung muss entfallen.
- Serviceprodukte wie Best Care und KombiMed Best Care oder den Tarif OptiMed O1A und O1P können Sie nicht weiterführen.

Im Basistarif besteht bei nachgewiesener Hilfebedürftigkeit die Möglichkeit der Prämienminderung (gemäß § 152 Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz). Bei bestehender Hilfebedürftigkeit verringert sich der Beitrag während der Dauer der Hilfebedürftigkeit um die Hälfte. Dies ist auch dann der Fall, wenn allein durch die Zahlung des vollen Beitrags Hilfebedürftigkeit eintreten würde.
Besteht auch bei einem geminderten Beitrag Hilfebedürftigkeit, beteiligt sich der Sozialhilfeträger an den Beiträgen.
Hilfebedürftigkeit ist vom zuständigen Sozialhilfeträger auf Antrag des Versicherten zu prüfen und zu bescheinigen.

Sofern für Ihren derzeitigen Tarif ein versicherungsmedizinischer Zuschlag (VMZ) vereinbart ist, bleibt dieser bei einem Wechsel in den Basistarif bestehen. Sie müssen ihn dann aber nicht als zusätzlichen Beitrag zahlen. Der VMZ, der vor der Umstellung in den Basistarif bereits bestanden hat, muss dann bei einer späteren Umwandlung wieder in voller Höhe gezahlt werden. Es können noch weitere versicherungsmedizinische Zuschläge hinzukommen, wenn sich der Gesundheitszustand nach dem Wechsel in den Basistarif verschlechtert hat.

| Tarif, Kurzerläuterung | Neuer zu zahlender Beitrag ggf. Obergrenze Euro |
|---|---|
| **BTN** | **655,23** |
| Tarif mit Übertragungswert, siehe Erläuterung*<br>Gesetzlich vorgeschriebener Tarif mit einheitlichen Leistungen, den alle Privaten Krankenversicherer seit dem 1.1.2009 anbieten müssen. Die Leistungen für den ambulanten, zahnärztlichen und stationären Bereich sowie für Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel und Krankentagegeld ab 43. Tag sind nach Art, Umfang und Höhe vergleichbar mit dem Niveau der Gesetzlichen Krankenversicherung. Das gilt unter anderem auch für Arztwahl und Zuzahlungen.<br>Selbstbeteiligung 0 EUR pro Jahr. | |

| | |
|---|---|
| TC 43<br>105 EUR Krankentagegeld ab dem 43. Tag | 46,39 |
| PVN<br>Private Pflegepflichtversicherung | 113,19 |
| **GBZ**<br>Gesetzlicher Beitragszuschlag | **65,52** |
| **Monatlicher Gesamtbeitrag:** | **880,33** |
| **Beitragsänderung gegenüber dem neuen Beitrag in den bisherigen Tarifen:** | **- 152,05** |

In dem neuen zu zahlenden Beitrag ist berücksichtigt:

| | |
|---|---|
| Beitragsminderung aus der Alterungsrückstellung*[1]: | 455,30 Euro |

---

**Besondere Hinweise zu den Vorschlägen für Dr. Rainer Nitsche:**

* Tarif mit Übertragungswert:
Bei dem Übertragungswert handelt es sich um einen Teil der Alterungsrückstellung. Diesen kann ein Versicherter bei einem Wechsel zu einem anderen privaten Krankenversicherer mitnehmen. Er entspricht maximal der Alterungsrückstellung, die wir für den brancheneinheitlichen Basistarif bilden würden. Dies ist in der Krankenversicherungsaufsichtsverordnung geregelt. Was passiert mit der restlichen Alterungsrückstellung? Sie kommt der Versichertengemeinschaft zugute. Tarife mit Übertragungswert sind teurer als Tarife, die keinen Übertragungswert bilden.
Die Alterungsrückstellung für die private Pflegepflichtversicherung kann ein Versicherter bei einem Wechsel vollständig mitnehmen.

*[1] Beitragsminderung aus der Alterungsrückstellung:
Wozu dient die Alterungsrückstellung? Ältere Versicherte nehmen Gesundheitsleistungen häufiger in Anspruch. Deshalb stellen wir einen Teil des Beitrages in jüngeren Jahren zurück und legen ihn verzinslich an. Damit können wir die im Alter zu erwartenden Mehrkosten decken und eine altersbedingte Erhöhung der Beiträge ausschließen. Alterungsrückstellungen bilden wir nur für Tarife, die wir nach Art der Lebensversicherung kalkulieren.

Ausnahme:
Alterungsrückstellungen für Kinder und Jugendliche werden nur ausnahmsweise gebildet. Hintergrund sind meist Limitierungen aus Beitragsanpassungen. Diese Alterungsrückstellungen sind so kalkuliert, dass diese bei Eintritt in den Beitrag für Erwachsene verbraucht sind.

Hinweis:
Sie haben mit uns eine Anwartschaftsversicherung vereinbart? Für diese Tarife (außer Pflegepflichtversicherung) weisen wir die Alterungsrückstellungen hier nicht aus. Sie bleiben wie vereinbart erhalten und werden fortgeführt. Endet die Anwartschaft, werden die Alterungsrückstellungen wieder beitragsmindernd angerechnet.

Bei Tarifumstellungen können Beitragsminderungen aus der Alterungsrückstellung und / oder Mittel aus dem gesetzlichen Beitragszuschlag nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden, wenn anderenfalls ein bestimmter Mindestbeitrag unterschritten würde. Die nicht gutgeschriebenen Beträge gehen nicht verloren. Wir führen sie mit Verzinsung in der Rückstellung für Prämienermäßigung im Alter weiter. Diese Mittel werden ab Alter 65 zur Begrenzung von Beitragserhöhungen verwendet. Ab Alter 80 werden noch vorhandene Mittel auch zur Beitragssenkung eingesetzt.

Versicherungsnummer:
**KV 313834668**

DKV Deutsche Krankenversicherung AG
50594 Köln

Februar 2026

**Erklärung zur Vertragsänderung**
für Dr. Rainer Nitsche, geboren am 29.8.1966

Allgemeiner Hinweis:
Der Beitragsersparnis steht in der Regel ein schlechterer Versicherungsschutz gegenüber. Wegen der Entwicklung im Gesundheitswesen können wir auch nach der Umstellung Beitragserhöhungen künftig nicht ausschließen.

Sie möchten trotzdem Ihren Vertrag umstellen? Dann kreuzen Sie hier den Vorschlag an, für den Sie sich entschieden haben, und schicken Sie uns bitte die Erklärung unterschrieben zurück.
Wenn Sie vorab eine telefonische Beratung wünschen, rufen Sie uns einfach an - wir sind gern für Sie da.

ANGSL

☐ **Vorschlag 1** A01
BestMed Komfort BM4 / 2, TC 43, PVN, GBZ

☐ **Vorschlag 2** A02
VollMed M4 - BR0, TC 43, PVN, GBZ
**Zu diesem Vorschlag ist die Gesundheitsfrage zu beantworten.**

☐ **Vorschlag 3** A03
**ET 1**, SB 2, TC 43, PVN, GBZ
Bei diesem Vorschlag erfolgt ein Wechsel in einen **leistungsschwachen Tarif**. Die im Vorschlag aufgeführten **wesentlichen Nachteile** sind mir bekannt.

☐ **Vorschlag 4** A04
**STN**, TC 43, PVN, GBZ
Bei diesem Vorschlag erfolgt ein Wechsel in einen **leistungsschwachen Tarif**. Die im Vorschlag aufgeführten **wesentlichen Nachteile** sind mir bekannt.

Ein Wechsel in den Standardtarif ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Diese habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige, dass sie vorliegen. Einen Nachweis füge ich bei.

☐ **Vorschlag 5** A05

**BTN**, TC 43, PVN, GBZ
Bei diesem Vorschlag erfolgt ein Wechsel in einen **leistungsschwachen Tarif**. Die im Vorschlag aufgeführten **wesentlichen Nachteile** sind mir bekannt.
**Zu diesem Vorschlag ist die Gesundheitsfrage zu beantworten.**

Ein Wechsel in den Basistarif ist nur möglich, wenn der gewöhnliche Aufenthalt der versicherten Person in Deutschland ist.

**Gesundheitsfrage***
**Zu Vorschlag 2 und 5** benötigen wir noch folgende Information von Ihnen:
Sind der DKV alle Behandlungen, Beschwerden, Unfallfolgen oder sonstigen Gesundheitsstörungen der letzten drei Jahre durch eingereichte Rechnungen bekannt?

☐ Ja.

☐ Nein.
In diesem Fall schicken wir Ihnen ein Schreiben mit ausführlichen Gesundheitsfragen zu.

**Ich beantrage auf Basis des angekreuzten Vorschlags die Änderung meines Vertrags. Die Gesundheitsfrage habe ich wahrheitsgemäß beantwortet. Die Verletzung meiner Anzeigepflicht kann die DKV zum Rücktritt, der Kündigung oder einer rückwirkenden Anpassung der Vertragsumstellung berechtigen. Bitte beachten Sie die ausführliche Rechtsfolgenbelehrung zu der Gesundheitsfrage*.**
**Die Vertragsänderung kommt erst zustande, wenn der Vorstand diese durch Aushändigung einer Versicherungsurkunde angenommen hat.**

**Bitte schicken Sie diese Erklärung nur zurück, wenn Sie Ihren Versicherungsschutz ändern möchten!**

| | |
|---|---|
| | |
| Ort, Datum | Unterschrift des Versicherten<br>(Dr. Rainer Nitsche) |

**Unsere Bitte an Sie:**
Schicken Sie uns **nur** diese Erklärung (Vorder- und Rückseite) zurück, gern auch per E-Mail.
Um Ihnen die Tarifänderung schnell bestätigen zu können, verarbeiten wir dieses Formular elektronisch. Daher können wir Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen **nicht** berücksichtigen. Für Vermerke und Mitteilungen verwenden Sie bitte ein separates Blatt. Vielen Dank!

**<u>* Rechtsfolgenbelehrung zu der Gesundheitsfrage:</u>**
**Beantworten Sie die Frage nach dem Gesundheitszustand nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig, gilt Folgendes: Wir können die Umstellung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit können wir von dem umgestellten Vertrag zurücktreten. Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz in dem von der Umstellung betroffenen Tarif. Der alte Tarif lebt wieder auf. Dies gilt nicht, wenn uns durch die Verletzung der Anzeigepflicht kein Nachteil entstanden ist. Unser Rücktritts- und Kündigungsrecht ist - außer bei Vorsatz - ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, z. B. mit einem Leistungsausschluss oder versicherungsmedizinischen Zuschlag. Bei einer von Ihnen zu vertretenden Pflichtverletzung können wir verlangen, dass die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil werden. Auch durch die rückwirkende Einfügung eines Leistungsausschlusses kann von Anfang an Ihr Versicherungsschutz für einen eingetretenen oder zukünftigen Versicherungsfall entfallen.**